Behandling med akut beroligende medicin, Fælles psykiatri, regional retningslinje			
Udgiver	Region Midtjylland		
Fagligt ansvarlig	Rasmus Skaarenborg Hjuler	Version	19
Kvalitetsansvarlig	Anne Foged Christensen	Gældende fra	19-11-2025
Ledelsesansvarlig	Anne Foged Christensen	Næste revision	01-04-2026
Ændringer	Forberedt integration.		

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at patienter, der udviser akut agitation, får den bedst mulige farmakologiske behandling med henblik på at dæmpe symptomerne. Herunder at optimere virkning og minimere bivirkning ved valg af behandling.

Tilbage til top

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe/Gyldighedsområde

Retningslinjen er rettet mod indlagte patienter i børne-, ungdoms-, voksen- og ældre psykiatrien, der udviser:

- Akut agitation, hvor patienten bliver til fare for sig selv eller andre
- Udadreagerende adfærd eller nærliggende risiko herfor, hvor medicinering er nødvendig for at minimere anvendelsen af tvang
- Angstsymptomer og andre psykiske tilstande, som er pinefulde for patienten

Tilbage til top

Definition af begreber

Akut agitation: En tilstand præget af svær oftest formålsløs uro, anspændthed, aggressivitet og forpinthed.

Tilbage til top

Fremgangsmåde

Gældende for Alle

I den akutte situation vurderes, om der kan være en somatisk eller anden oplagt årsag til den eskalerende situation, og optimering af tidligere afprøvet lægemiddel forsøges.

Den behandlingsansvarlige læge skal lægge en plan for medicinering i den akutte situation allerede ved indlæggelsen. Den akutte medicinplan anbefales justeret løbende.

Vær opmærksom på, hvordan det akutte præparatvalg interagerer med patientens øvrige medicin, og om der er et kendt misbrug. Se den fællespsykiatriske retningslinje vedr. Forholdsregler ved anvendelse af antipsykotika, fællespsykiatrisk retningslinje samt Interaktionsdatabasen.

Ved diagnostisk afklarede patienter eller ved medicinsvigt bør beslutningen om valg af akut beroligende medicin tage hensyn til, hvilken behandling patienten er i eller forventes at være i, når den akutte fase er overstået.

Man skal opfylde kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Der skal ved valg af præparat tages højde for virkningstid. Generelt skal det begrundes konkret i journalen, hvorfor man har valgt det ene præparat frem for det andet, hvis der er forskel i virkningstiden. Hvis patienten i forvejen er i antipsykotisk behandling kan dosis heraf øges.

Overskridelse af de angivne døgndoser kan i nogle tilfælde være nødvendigt, hvilket altid fører til skærpede krav til dokumentationen i forhold til behandlingsindikation og bivirkninger. I den akutte situation vil overskridelse af doserne kræve godkendelse af overlæge.

Behandling med akut beroligende medicin kræver samtykke fra patienten. Ved behov for behandling med beroligende medicin med tvang se: Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt, fælles psykiatri, regional retningslinje.

Gældende for ≤ 17 år Børn og unge

Hos børn og unge gælder det i særlig høj grad, at miljøterapeutiske interventioner kan være effektive imod angst og affektreaktioner. Miljøterapeutiske interventioner kan f.eks. være:

- Fjernelse af angstvoldende stimuli (mørke, lyde, uforudsigelige input, smerter mv.)
- Tilstedeværelse af trygge nærværende voksne
- Afsøgning af mulige angstvoldende og affektoptrappende forventninger (skal der ske noget særligt de næste dage f.eks. blodprøver, testning, besøg, udskrivelse)
- Vigtigt at være opmærksom på patientens forhåndstilkendegivelse og mestringsplan
- Skærmning, aktiviteter
- Arbejd ud fra deeskalerende metoder
- Tydelige rammer og forventninger m.v.

I børne- og ungdomspsykiatrien vil den akutte beroligende medicinske behandling typisk foregå således:

1. Patienten tilbydes frivillig peroral behandling
2. Patienten får peroral behandling med tvang
3. Patienten får injektion i.m. med tvang

Særlige opmærksomhedspunkter ved behandling med akut beroligende til børn og unge:

- Der findes ingen medicin med indikationen akut beroligende medicin ved angst, uro og agitation hos børn.
- Nedenstående er således ”off label”-indikationer, og særlig omhyggelig individuel stillingtagen, inklusiv evt. drøftelse med bagvagt, er således væsentlig ved enhver brug.
- Akut beroligende medicin anvendes kun i yderst sjældne tilfælde til børn under 10 år.
- Benzodiazepiner bør i højere grad anvendes og risiko for paradoxe reaktioner er lav.
- OBS - samtidig injektion med i.m. olanzapin og i.m. benzodiazepiner må ikke forekomme grundet risiko for respirationsdepression.

  Følgende gælder tilsvarende voksenpsykiatrisk retningslinje:

  - Har man behov for at give im Lorazepam efter im Olanzapin skal der gå minimum 1 time
  - Har man behov for at give im Olanzapin efter im Lorazepam skal der gå min 2timer
- Toksisk psykose (udløst af centralstimulantia) bør i den akutte fase ikke behandles med antipsykotika på grund af risiko for udvikling af kramper og malignt neuroleptikasyndrom. Denne type agitation behandles med benzodiazepiner

For hvert præparat anbefales at man sammenholder viden fra promedicin.dk ift anvendelse i børne- og ungealderen.

OBS – Denne retningslinje er udelukkende gældende i psykiatrien, RM.

For patienter som er dobbeltindlagte med behov for akut beroligende medicin medbringes dette fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit.

Flowchart – Behandling
Akut agitation < 18 år

Miljøterapi forsøgt?

- **NEJ** → **Anvend miljøterapi**
- **JA** ↓

Tidligere episoder?

- **JA** → **Anvend det præparat patienten plejer at profitere af**
- **NEJ** ↓

1. Benzodiazepin vurderes uhensigtsmæssigt* eller antipsykotisk effekt ønskes
   OG
2. Der foreligger tilstrækkelige oplysninger til at udelukke interaktion mellem antipsykotika og stoffer/medikamina/somatisk sygdom

NEJ / UVIST
Anvend Benzodiazepin

FRIVILLIG

Tbl. Lorazepam
Børn over 12 år:
0,05 mg/kg
1-2mg (op til 4 mg), kan gentages efter ½-2 timer

Tbl. Stesolid
Børn over 3 år:
2-4 mg 1-3 gange dgl

Stesolid har lang halveringstid, variabel absorption og kan give vævsirritation.
Lorazepam bør således være første valg.

Ved mistanke om forgiftning:
Ring ABC-kald
Antidot i form af Flumazenil
0,3mg iv over 15 sek.
Det henvises i øvrigt til beskrivelse i den voksenpsykiatriske retningslinje

TVANG

Tbl. Lorazepam
Børn over 12 år:
0,05 mg/kg
1-2mg (op til 4 mg), kan gentages efter ½-2 timer

Inj. Lorazepam
Børn over 12 år:
0,05 mg/kg
1-2 mg (op til 4 mg), kan gentages efter ½-2 timer

Tbl. Stesolid
Børn over 3 år:
2-4 mg 1-3 gange dgl.

Inj. Stesolid
Halv dosis ift. peroralt

Stesolid har lang halveringstid, variabel absorption og kan give vævsirritation.
Lorazepam bør således være første valg.

Ved mistanke om forgiftning: (se i kolonnen til venstre)

JA TIL PUNKT 1 OG 2
Anvend antipsykotika

FRIVILLIG

Tbl. Risperidon
Børn 5-18 år:
Vægt < 50 kg: 0,25-0,50 mg, max 0,75 mg dgl.
Vægt > 50 kg: 0,50 -1,0 mg, max 1,5 mg dgl.

Tbl. Aripiprazol
Børn over 13 år:
2,5-10 mg pn, max 30 mg dgl.

Tbl. Quetiapin
Off label til børn
F.eks. 25-50 mg pn, max 200 mg dgl.

Tbl. Olanzapin
Off label til børn
F.eks. 2,5-10 mg, max 20 mg dgl.

TVANG

Tbl. Aripiprazol
Børn over 13 år:
2,5-10 mg pn, max 30 mg dgl.
Inj. Aripiprazol
5 mg-9,75 mg i.m. pn, max 30 mg dgl.

Tbl./smelttbl Risperidon**
Børn 5-18 år:
Vægt < 50 kg: 0,25-0,50 mg, max 0,75 mg dgl.
Vægt > 50 kg: 0,50 -1,0 mg, max 1,5 mg dgl.

Tbl. Haloperidol***
6-11 år: 0,5-3 mg dgl.
12-17 år: 0,5-5 mg dgl.
Inj. Haloperidol
Halv dosis ift. peroralt

Tbl/inj. Olanzapin****
Off label til børn
F.eks. 2,5-10 mg, max 20 mg dgl.
Halv dosis ved injektion.

*Eksempler: Tidligere (eller stor risiko for) afhængighed af benzodiazepiner, tidligere paradoks reaktion etc.
** Da Risperidon ikke findes i injektion skal der ved behov for injektion med tvang indledningsvis tilbydes fx Abilify som tablet forud for at der gives injektion med Abilify
*** Øget risiko for EPS herunder akut dystoni ved behandling med Haloperidol hos børn og unge. Bør anvendes meget sjældent
**** Olanzapin med tvang må som udgangspunkt ikke anvendes. Hvis det alligevel vurderes nødvendigt, skal det konfereres med bagvagt, og der skal laves grundig dokumentation om overvejelserne bag. F.eks. akut farlighed og behov for at anvende et præparat med umiddelbar sederende/beroligende og antipsykotisk effekt. Det skal fremgå at det vurderes at være mindste middels princip at anvende Olanzapin.
OBS. Særlig risiko og forholdsregler ved samtidig indgift af Olanzapin og benzodiazepiner. Se under særlige opmærksomhedspunkter

Husk altid forældresamtykke.

Flowchart for behandling af akut agitation - børn og unge.

Supplerende information til anvendelse af flowchart. Se bilag: Supplerende information til anvendelse af flowchart for behandling af akut agitation under 18 år

Gældende for ≥ 18 år voksne

I den akutte fase er første led i behandlingen at minimere uro, stress og sørge for strukturerede og forudsigelige omgivelser.

Trin i intervention

1. Skærmning med henblik på reduktion af sanseindtryk
2. Deeskalering, timeout, placering osv. efter behov
3. Tilbyd peroral behandling (frivilligt eller tvang)
4. Overvej i.m.-behandling (frivilligt eller tvang)
5. Overvej i.v.-behandling på somatisk afdeling

Patientens tilstand skal løbende vurderes og monitoreres nøje, samtidig med løbende rådgivning og konference med bagvagten/overlægen.

Det medicinske behandlingsvalg afhænger af:

- Om patienten er diagnostisk afklaret og kendt i forvejen
- Om patienten kan medvirke til frivillig peroral behandling, hvilket altid foretrækkes
- Respons på aktuel og tidligere medikamentel behandling
- Sværhedsgraden af uroen
- Patientens mulige præferencer ved ligestillede behandlingsmuligheder

Generelle retningslinjer

- Patienter med debuterende psykose, som ikke tidligere har modtaget antipsykotisk behandling, bør primært behandles med benzodiazepiner
- Patienter med toksisk psykose (udløst af centralstimulantia) bør i den akutte fase ikke behandles med antipsykotika på grund af risiko for udvikling af kramper og malignt neuroleptika syndrom (MNS). Denne type agitation behandles udelukkende med benzodiazepiner
- Behandling af ældre skal varetages med forsigtighed. Ældre patienter skal som udgangspunkt behandles med doser svarende til ¼ - ½ af de anførte doser for voksne
- Ved behandling med antipsykotika bør monoterapi tilstræbes, da kombinationsbehandling med forskellige antipsykotika øger risiko for QT-forlængelse

Algoritme for medicinsk behandling af akut agitation

Akut agitation kan ses ved forskellige tilstande:

- Akut agitation i forbindelse med delirium
- Akut agitation i forbindelse med intoksikation
- Akut agitation ved psykiatriske tilstande *uden* psykotiske symptomer
- Akut agitation ved psykiatriske tilstande *med* psykotiske symptomer

Medicinsk behandling af akut agitation i forbindelse med delirium

Patienter med delir behandles i den akutte fase efter følgende retningslinje:

Delirium, identifikation, forebyggelse, behandling og pleje. Regional retningslinje.

Medicinsk behandling af akut agitation i forbindelse med intoksikation

Patienter med intoksikation og abstinenser behandles i den akutte fase efter følgende retningslinjer:

- COVID-19. Håndtering af akutte opioidabstinenser, regional retningslinje*
- COVID-19. Håndtering af forgiftninger og abstinenser til centralstimulerende stoffer, regional retningslinje*
- COVID-19. Håndtering af benzodiazepin-forgiftning og abstinenser, regional retningslinje*
- Farmakologisk alkohol abstinensbehandling for somatiske og psykiatriske patienter, regional retningslinje

*Der er en ny retningslinje på vej i høring, der bl.a. samler de 3 stjernemarkerede retningslinjer.

For patienter i behandling med **metadon** gælder:

Der er øget risiko for komplikationer ved samtidig behandling med metadon og antipsykotika og/eller

benzodiazepiner. Kombinationsbehandling skal derfor nøje overvejes, og såfremt der findes behov herfor, monitoreres der med EKG efter klinisk vurdering.

Ligeledes skal der udvises generel tilbageholdenhed med akut beroligende behandling med antipsykotika og/eller benzodiazepiner til patienter, der allerede er i behandling med metadon (eller som kan have indtaget metadon på egen hånd). Dette gælder i særlig grad for parenteral behandling med akut beroligende medicin.

Hvis det skønnes nødvendigt, at en patient, der får Metadon, skal behandles med akut beroligende medicin (antipsykotika og/eller benzodiazapiner), skal patienten observeres med fast vagt så længe den akutte behandling foregår. Man skal være opmærksom på halveringstiderne/eliminationen af de enkelte præparater herunder antidot. I forbindelse med den faste vagt skal der være adgang til Rubensballon og antidot, hvor en sådan findes. I hver vagt revurderes observationsniveauet af læge og ansvarshavende sygeplejerske/kontaktperson.

Medicinsk behandling af akut agitation ved psykiatrisk lidelse *uden* psykotiske symptomer samt psykiatrisk lidelse *med* psykotiske symptomer

For behandling af ældre patienter læs også afsnittet "Medicinsk behandling af akut agitation hos ældre patienter".

Tabel 3

Medicinsk behandling af akut agitation ved psykiatrisk lidelse *uden* psykotiske symptomer samt psykiatrisk lidelse *med* psykotiske symptomer ≥ 18 år	
Peroral behandling	
Peroral behandling ved psykiatrisk lidelse *uden* psykotiske symptomer. Inklusiv patienter med debuterende psykose, som ikke tidligere har modtaget antipsykotisk behandling:	
Præparat	**Bemærkning**
• Tbl. lorazepam 1-2 mg	Biotilgængelighed: P.o.=i.m.=i.v.: 100% Tmax p.o: 2 timer. T½: 12 timer (formentlig po= im)
Note: • Tbl. promethazin 25 mg kan benyttes ved tidligere paradoks virkning ved benzodiazepin.	Off-label brug, da præparat ikke har indikation mod uro/agitation. Udvis særlig opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler.
Peroral behandling ved psykiatrisk lidelse *med* psykotiske symptomer:	
Præparat	**Bemærkning**
1. valg: • Tbl. olanzapin 5-10 mg, eller • Tbl. risperidon 1-2 mg, eller • Tbl. quetiapin 50-100 mg	Antipsykotisk behandling skal så vidt muligt forudgås af EKG. Smeltetabletter kan anvendes ved usikker compliance eller hvis patienten har svært ved at sluge tabletter. Olanzapin: biotilgængelighed p.o. 85 %, Tmax p.o. (tablet = smelt) 5-8 timer, T½ p.o.=i.m. 30 timer Risperidon: biotilgængelighed 70 %, Tmax p.o. 1-2 timer, T½ p.o. 3 timer (23 timer metabolit)

	Quetiapin: biotilgængelihed p.o 10 %, Tmax p.o. 1,5 timer, T½ p.o. 7 timer (12 timer metabolit)
2. valg: • Tbl. eller dråber zuclopenthixol (cisordinol) 10 mg	Antipsykotisk behandling skal så vidt muligt forudgås af EKG. Zuclopenthixol: biotilgængelihed p.o. 44 %, Tmax p.o. 4 timer, T½ p.o. 20 timer
3. valg: • Tbl. haloperidol sædvanligvis 5-10 mg fordelt på 2 doser	Behandling med haloperidol skal så vidt muligt forudgås af EKG. Undgå relaterede antipsykotika. Haloperidol biotilgængelighed p.o. 65 %, Tmax p.o. 2-6 timer, T½ p.o. 24 timer (15-37 timer)
Den perorale behandling kan gentages efter 45-60 minutter, hvis nødvendigt. Overvej at kombinere benzodiazepiner og antipsykotisk behandling. Gå til i.m.-behandling, hvis to doser mislykkes, eller før hvis patienten sætter sig selv eller andre i betydelig risiko eller fare.	
Overvej i.m.-behandling	
I.m.-behandling ved psykiatrisk lidelse *uden* psykotiske symptomer. Inklusiv patienter med debuterende psykose, som ikke tidligere har modtaget antipsykotisk behandling:	
Præparat	**Bemærkning**
• Inj. lorazepam 1-2 mg i.m.	Kan ved behov gentages efter 1-2 timer. Biotilgængelighed 100 % i.m. Tmax i.m. 1-1,5 timer (effekt efter 15-30 minutter), T½ i.m. 12 timer. Så tidligt i forløbet som muligt tages: Elektrolytstatus og EKG. Parenteral benzodiazepinbehandling kræver monitorering jf. tabel 5 i afsnittet: "monitorering af parenteral behandling med benzodiazepiner". Døgndosis > 4 mg skal indtil videre godkendes af overlæge. Hav flumazenil til rådighed i tilfælde af respirationsdepression. For dosis se tabel 5 i afsnittet "monitorering af parenteral behandling med benzodiazepiner"
I.m.-behandling ved psykiatrisk lidelse *med* psykotiske symptomer:	
Præparat	**Bemærkning**
1. valg: • Inj. olanzapin 5-10 mg i.m. • Inj. aripiprazol 9.75 mg i.m.	**I.m.-olanzepin må aldrig kombineres med i.m.-benzodiazepin.** Har man behov for at give im Lorazepam efter im Olanzapin, må det tidligst ske efter 1 time. Har man behov for at give im Olanzapin efter im Lorazepam, må det tidligst ske efter 2 timer.

	For olanzapin gælder, at initialdosis almindeligvis er en injektion på 5-10 mg i.m. Ældre 2,5-5 mg i.m. Dosis kan **gentages** efter 2 timer og evt. igen 4 timer efter 2. injektion. Der bør højst gives 3 injektioner og samlet op til 20 mg i døgnet. Sikkerheden ved doser over 30 mg i døgnet er ikke undersøgt. Tmax i.m. 15-45 minutter, T½ i.m.=p.o 30 timer. Ved aripiprazol er der mindre risiko for blodtryksfald end ved olanzapin, men muligvis mindre effektiv. For aripiprazol gælder, at dosis kan gentages efter behov efter mindst 2 timer. Højst 3 injektioner dagligt og samlet højst 30 mg aripiprazol dagligt. Tmax i.m. 1-3 timer, T½ i.m. 75 timer (94 timer metabolit). Biotilgængelighed ved i.v. behandling er for begge præparater 100 %. Ved i.m. behandling forventes næsten det samme.
2. valg: • Inj. zuclopenthixolacetat (cisordinol-acutard) 100 mg i.m.	Zuclopenthixolacetat kan anvendes, hvor der ønskes en protraheret effekt af 1-3 døgns varighed til kupering af et akut psykotisk/maniformt opsving eller en eksacerbation i et kronisk psykotisk forløb. Doseringen gentages ved behov, almindeligvis efter 2-3 døgn. Der bør højst gives 4 injektioner og højst en akkumuleret dosis på 400 mg. Behandlingen bør højst vare 14 dage. Må kun gives, hvis pt. tidligere har fået og tålt cisordinol. Biotilgængelighed ved i.v. behandling er 100 %. Ved i.m. behandling forventes næsten det samme. Tmax i.m. 24-48 timer (effekt efter 2-6 timer), T½ i.m. 32 timer.
3. valg: • Inj. haloperidol 5 mg i.m.	**Haloperidol bør være det sidste behandlingsmiddel, der overvejes.** Dosis kan justeres med 2-4 timers mellemrum til højest 20 mg i døgnet. Forekomst af akut dystoni er høj. Det sikres, at inj. akineton (i.m. eller i.v.) er tilgængelig. Behandling med injektion akineton 5-10 mg x 2-3 dagligt. Dvs. max. 30 mg dagligt. Gentagelse af dosis efter minimum ca. 2–3 timer. Biotilgængelighed ved i.v. behandling er 100 %. Ved i.m. behandling forventes næsten det samme. Tmax i.m. 20-40 minutter, T½ i.m. 21 timer (13-36 timer)
Kombination af haloperidol og lorazepam kan overvejes, hvis behandlingen med et enkelt lægemiddel mislykkes. Lægemidler må ikke blandes i den samme sprøjte.	
Overvej i.v.-behandling	
Konferer altid med bagvagt/overlæge og evt. med somatikken i forhold til overflytning inden i.v.-behandling.	
Præparat	**Bemærkning**

1. valg: • I.v. diazepam 5-10 mg. Indgives over mindst 2 minutter. Fra januar 2021 kommer diazepam i restordre og lorazepam kan benyttes: • I.v. lorazepam 1-2 mg	I.v. benzodiazepinbehandling kræver fast vagt med tæt observation og monitorering jf. tabel 5 i afsnittet: "monitorering af parenteral behandling med benzodiazepiner". Hav flumazenil til rådighed i tilfælde af respirationsdepression. Ved behandling af patienter med psykotisk delir med benzodiazepiner skal man være opmærksom på, at akut EKG kan blive nødvendig.
2. valg: • I.v. haloperidol 0,5-2 mg	For haloperidol anbefales et EKG før behandling. Obs risiko for QT-forlængelse ved i.v. haloperidol.

Reference:

Tilpasset til psykiatrien i Region Midtjylland på baggrund af: Taylor, D., Barnes, T., & Young, A.; The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry; 2018, 13th edition; Wiley Blackwell

Medicinsk behandling ved akut agitation hos ældre patienter

Akutte psykiatriske symptomer hos ældre har ofte somatisk genese.

Behandling af ældre skal generelt varetages med forsigtighed. Ældre patienter skal som udgangspunkt behandles med doser svarende til 1/4 eller 1/2 af de anførte doser for voksne.

Der bør i så vidt omfang som muligt, ikke ordineres injektionsbehandling med antipsykotika til denne patientgruppe. Hvis nødvendigt, som hovedregel: Start med lav dosering og titrer forsigtigt op. Monitorer for potentielle bivirkninger.

Der bør også udvises særlig opmærksomhed, hvis man mistænker Lewy Body Demens eller Parkinson sygdom, da disse patienter er særdeles følsomme og ofte ikke tåler antipsykotika.

Injektion olanzapin bør undgås til ældre med demens og til ældre, hvor man mistænker en demensdiagnose. Man skal være opmærksom på den uspecifikke sederende effekt.

Der henvises til Demens og Medicin (NKR).

Vedr. adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens (BPSD) henvises til: Metoder til at forstå adfærdsmæssige og psykiske symptomer i praksis. Anbefaling til non-farmakologisk behandling, bør iværksættes inden farmakologisk behandling.

Tabel 4

Ældre patienter	
Præparatvalg	**Ved demens og delir**
Første præparatvalg	**Ved demens** **Ved demens bør antipsykotisk** behandling kun iværksættes ved forpint eller farligt tilstand og hvis non-farmakologisk tiltag ikke hjulpet. Risperidon og quetiapin er førstevalgspræparater. Risperidon er kontraindiceret hos patienter med Lewy Body demens. • Tbl./smeltetbl. risperidon startdosis: 0,25 mg til 1 mg dagligt, doser over 2

	mg dagligt bør undgås. Indikation: Vedvarende aggression ved moderat til svær Alzheimers sygdom. Behandlingen bør højst vare 6 uger og skal evalueres hyppigt og regelmæssigt *(se yderligere i* Promedicin.dk) • Tbl. quetiapin startdosis: 25 mg til 50 mg dagligt, doser over 200 mg dagligt bør undgås. Obs. risiko for blodtryksfald. Brug af 1. generations antipsykotika eller acutard præparater er kontraindicerede. **Ved delir** Der henvises til den fællespsykiatriske retningslinje vedr. Delirium, identifikation, forebyggelse, behandling og pleje. Regional retningslinje.

Monitorering af parenteral behandling med benzodiazepiner

Tabel 5

Monitorering af parenteral behandling med benzodiazepiner	
Observation	**Behandling**
Tæt observation afhængigt af patientens tilstand. Hvis patienten fremtræder sederet påsættes kontinuerlig saturationsmåler /pulsoximeter. Når der gives lorazepam i.m. skal der være nem adgang til i.v.-adgang, og læge skal kunne tilkaldes akut. Måling af følgende værdier: **Respirationsfrekvens og bevidsthedstilstand** hvert 10. min den første time og herefter hver 30. min i alt to gange, svarende til i alt 2 timers observationstid. Hvis muligt: Puls, BT og temperatur. Elektrolytter og EKG tages så hurtigt som muligt og senest næste dag. Der skal være umiddelbar adgang til • **Rubens ballon** • **Pulsoximeter** • **Akuttaske, ilt og sug** • **Antidot (flumazenil)**	Ved påvirket respirationsfrekvens påsættes pulsoximeter. Ved **respirationsfrekvens < 10/min: mål saturation. Hvis SAT er < 92% også efter forsøg på omlejring:** • Giv **flumazenil 0,3 mg i.v**. over 15 sekunder Såfremt respirationen ikke normaliseres i løbet af 60 sekunder: • Giv en flumazenil-dosis mere på 0,1 mg • Gentag ved behov med intervaller på 60 sekunder op til total dosis på 1-2 mg. Hvis tilstanden ikke responderer på de første 2 doser skyldes sedationen ikke benzodiazepin-forgiftning, og andre årsager til sedation skal undersøges, ligesom overflytning til medicinsk/intensiv afdeling skal overvejes. Kramper kan udløses af flumazenil-indgift hos patienter, der er i kronisk behandling med (eller som misbruger) benzodiazepiner.

Tilbage til top

Dokumentation

Følgende dokumenteres:

- **SFI "Forslag til akut psykiatrisk medicinplan"**: Dokumentation af plan for beroligende medicin i den akutte situation. Planen er et forslag og ikke en ordination. Forslaget til den akutte psykiatriske medicinplan kan indeholde forslag om enkelt præparater, men også flere trin i den akutte medicinering i forhold til evt. eskalerende situation. Forslaget til den akutte medicinplan kan endvidere indeholde betingelser, som den senere ordinerende læge skal være opmærksom på.

- **Medicinmodul:** Selve ordination af medicin dokumenteres i Medicinmodulet. Forslaget til den akutte medicineringsplan ordineres først i medicinmodulet i journalen, når det reelle behov for akut medicinsk behandling opstår.
- **SFI "Medicin":** Dokumentation af bl.a. indikationer/begrundelser for medicinordinationer/seponering af medicin, op- eller nedjusteringer af dosis.
- **SFI "Vurdering af bivirkninger":** Dokumentation af evt. bivirkninger til den akutte medicinske behandling.

Tilbage til top

Ansvar

Afdelingsledelsen har ansvaret for at retningslinjen implementeres.

Ordination af akut beroligende medicin er et lægeligt ansvar.

Behandling med olanzapin i døgndoser, der overstiger 40 mg, kan i få tilfælde være nødvendig. Det indskærpes, at al behandling, der overstiger den øvre grænse på 40 mg, skal godkendes af ledende overlæge. Der er samtidig et skærpet dokumentationskrav ift. behandlingsindikation og bivirkninger.

Plejepersonalet har ansvaret for observationer af symptomer til brug for indikation for ordinationen, virkning og bivirkninger, samt med miljømæssige tiltag, information og psykoedukation.

Tilbage til top

Referencer

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende antipsykotika til behandling af psykotiske tilstande hos voksne

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende antipsykotika til behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Interaktionsdatabasen

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Afhængighedsskabende lægemidler, fælles psykiatri, regional retningslinje

Promedicin.dk

Taylor, D., Barnes, T., & Young, A.; The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry; 2018, 13th edition; Wiley Blackwell

Tilbage til top